

Protocolo de Atencion en Emergencias Cardiovasculares

Documento educativo para el proyecto MedAssistant - dev/talles

Este documento fue creado exclusivamente con fines educativos para demostrar la funcionalidad de RAG en el curso de Spring AI. No constituye un protocolo medico oficial.

1. Dolor Toracico Agudo

Ante un paciente que consulta por dolor toracico agudo, se deben seguir los siguientes pasos de evaluacion inicial: tomar signos vitales completos incluyendo presion arterial en ambos brazos, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturacion de oxigeno y temperatura. Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones dentro de los primeros 10 minutos desde la llegada del paciente. Obtener acceso venoso periferico e iniciar monitoreo cardiaco continuo.

Si el electrocardiograma muestra elevacion del segmento ST en dos o mas derivaciones contiguas, se debe activar el protocolo de infarto agudo de miocardio con elevacion del ST (IAMCEST). El tratamiento inicial incluye aspirina 300 mg via oral (masticada), clopidogrel 300 mg como dosis de carga, y heparina no fraccionada o de bajo peso molecular segun el peso del paciente. Se debe coordinar el traslado inmediato a la sala de hemodinamia para angioplastia primaria.

2. Crisis Hipertensiva

Una crisis hipertensiva se define como una elevacion aguda y severa de la presion arterial, generalmente con valores superiores a 180/120 mmHg. Se clasifica en urgencia hipertensiva (sin dano de organo blanco) y emergencia hipertensiva (con evidencia de dano de organo blanco como encefalopatia, sindrome coronario agudo, edema pulmonar o disecccion aortica).

En la urgencia hipertensiva, el objetivo es reducir la presion arterial de forma gradual en un periodo de 24 a 48 horas, utilizando medicamentos orales como captopril sublingual, nifedipino de liberacion prolongada o clonidina. No se recomienda una reduccion brusca de la presion arterial ya que puede provocar hipoperfucion de organos vitales.

En la emergencia hipertensiva, se requiere hospitalizacion en unidad de cuidados intensivos con medicacion intravenosa como nitroprusiato de sodio, labetalol o nicardipina, con el objetivo de reducir la presion arterial en un 25 por ciento durante la primera hora.

3. Manejo del Dolor en Pacientes Cardiovasculares

El manejo del dolor en pacientes con enfermedades cardiovasculares requiere consideraciones especiales. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno deben evitarse en el contexto agudo del dolor toracico por el riesgo cardiovascular aumentado. La morfina en dosis

de 2 a 4 mg por vía intravenosa puede utilizarse si el dolor persiste después del tratamiento inicial con nitroglicerina.

Para el dolor crónico en pacientes con hipertensión arterial, se prefiere el paracetamol como analgésico de primera línea. Si se requiere un AINE, se debe utilizar la dosis más baja efectiva durante el menor tiempo posible, con monitoreo frecuente de la presión arterial y la función renal. Los inhibidores selectivos de la COX-2 (como celecoxib) no ofrecen ventajas cardiovasculares significativas sobre los AINEs tradicionales.

4. Prevención Primaria Cardiovascular

La prevención primaria cardiovascular se basa en la identificación y el control de los factores de riesgo modificables. Los pilares fundamentales son: control de la presión arterial manteniendo valores por debajo de 130/80 mmHg; control glucémico adecuado en pacientes diabéticos; mantenimiento de niveles de colesterol LDL por debajo de 100 mg/dL en pacientes de alto riesgo; cesación del tabaquismo; realización de al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada; y mantenimiento de un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9.

La evaluación del riesgo cardiovascular global debe realizarse utilizando herramientas validadas como las tablas de riesgo de la Organización Mundial de la Salud o el score de Framingham. Los pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto pueden requerir tratamiento farmacológico con estatinas y aspirina en dosis bajas como prevención primaria, además de las modificaciones del estilo de vida.

5. Signos de Alarma para el Paciente

Se debe instruir al paciente para que acuda a urgencias inmediatamente si presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma: dolor torácico opresivo que dura más de 20 minutos, especialmente si se irradia al brazo izquierdo, mandíbula o espalda; dificultad respiratoria súbita; pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo; dificultad para hablar o entender el lenguaje; cefalea intensa de inicio súbito diferente a las habituales; pérdida de visión súbita en uno o ambos ojos; o síncope (pérdida de conciencia).

Ante cualquiera de estos síntomas, el paciente no debe conducir por sí mismo al hospital. Debe llamar a los servicios de emergencia y permanecer en reposo hasta la llegada de la asistencia médica.